

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0263

Paginas del documento: 10

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

they had never attended therapy pandemic, while only 17.5% said they confirmed the medication utilization, e practice. Furthermore, 98.2% said they use technological devices daily, while only 1.75% didn't. Using the software, the interviews were divided into 5 classes: social isolation; loneliness and mental health; Changing daily habits; Use of technology during social isolation; Acceptance or fear of aging; Mental health related to the perception of death.

Conclusion: with this research, it was concluded that there is a relationship between chronic diseases and psychiatric disorders in the elderly, worsening of mental health during this period, refusal of therapy, a significant increase in self-medication, and increased use of technology.

Keywords: mental health, aged, drug utilization, COVID-19 pandemic, life style.

Resumen

Objetivo: entender el impacto de la pandemia en la salud mental y el comportamiento de las personas mayores, a través del análisis de los efectos de la pandemia sobre la salud mental, la automedicación y el uso de tecnologías.

Método: se realizó un estudio de campo cualitativo, con enfoque directo, aleatorio, no intencional, mediante entrevistas semiestructuradas, realizadas de forma en línea o presencial en el campus de Taguatinga de la Universidad Católica de Brasília. Se utilizó un cuestionario con preguntas objetivas y subjetivas. El posterior análisis estadístico se realizó con el software IRAMUTEQ, mediante pruebas de Chi-Cuadrado para los cuestionarios, con análisis de contenido de Bardin.

Resultados: 171 ancianos participaron en la investigación, con una edad prevalente de 60 a 65 años; el 70,2% eran mujeres y el 29,8% eran hombres; el 82,5% de los ancianos afirmaron no haber asistido nunca a sesiones de terapia antes de la pandemia, mientras que solo el 17,5% afirmaron tal hábito. El 83% afirmó hacer uso de medicamentos diarios, mientras que el 17% negó la práctica. Además, el 98,2% confirmó el uso diario de dispositivos tecnológicos, mientras que solo el 1,75% lo negó. Con el software utilizado, se realizó la división de las entrevistas en 5 clases: aislamiento social: soledad y salud mental; cambio de hábitos diarios; utilización de la tecnología durante el aislamiento social; aceptación o miedo al envejecimiento; salud mental relacionada con la percepción de la muerte.

Conclusión: así, se concluyó que hay relación entre las enfermedades crónicas y los trastornos psiquiátricos en los ancianos, empeoramiento de la salud mental durante este periodo, rechazo a la terapia, aumento significativo de la automedicación y aumento del uso de la tecnología.

Palabras clave: salud mental, anciano, utilización de medicamentos, pandemia de la COVID-19, estilo de vida.

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a pandemia de COVID-19¹, que rapidamente se espalhou pelo mundo, afetando milhões de pessoas. A pandemia provocou mudanças e rápida disseminação de informações. Com o aparecimento de notícias relacionadas ao novo coronavírus, os idosos com doenças crônicas eram os mais afetados por sintomas severos, com taxas de mortalidade mais altas quando comparadas a outras faixas etárias², provocando um grande impacto na vida das pessoas pela exposição ao vírus e pelas medidas de isolamento impostas.³

Inicialmente, os idosos foram identificados como um grupo de risco, devido à imunossenescência.⁴ Com o isolamento social recomendado como medida de segurança⁵, a saúde mental dessa população foi impactada, levando a discussões sobre etarismo e mortalidade. Ademais, a iatrogenia (alteração patológica provocada no paciente pela má prática médica) e a automedicação ganharam destaque, sendo as principais: a iatrofarmacogenia², internação hospitalar e intervenções sem comprovação científica.⁶ A automedicação apresenta riscos significativos, já que os efeitos das interações medicamentosas são preocupantes e as reações adversas podem ser deletérias.⁷

Devido ao isolamento social, houve aumento no uso da tecnologia e mudanças nos hábitos diários, impulsionados pela disseminação midiática de informações inverídicas, o que intensificou a ansiedade e o medo⁸. Dado o volume avassalador de informações, destacam-se as diversas interpretações de notícias falsas, que impactaram significativamente o comportamento individual.⁹ Durante a quarentena, os indivíduos tinham necessidade de comunicação, de entretenimento e de acesso a informações sobre a doença, sem se preocupar com a veracidade das notícias.^{10, 11}

Assim, este estudo objetiva entender o

² Iatrofarmacogenia é um tipo de iatrogenia, uma síndrome geriátrica que resulta de intervenções médicas com consequências para

dos idosos. Por meio da análise
ndemia sobre a saúde mental, a
o uso de tecnologias, busca-se
desenvolver melhores práticas para proteger e
apoiar a população idosa.

Métodos

Estudo de campo qualitativo, com abordagem
direta, aleatória, não intencional, realizado
por meio de entrevistas semiestruturadas,
presencialmente no campus de Taguatinga da
Universidade Católica de Brasília (UCB) ou on-
line entre 01/09/2022 e 30/11/2022.

Participaram 171 idosos de ambos os sexos,

Pará, Goiás, Paraíba, São Paulo, Ceará e Rio Grande
do Norte. Os critérios de inclusão foram: indivíduos
com 60 anos ou mais, independentemente de
suas práticas religiosas ou espirituais. Os critérios
de exclusão incluíram: a recusa em assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) e a incapacidade de comunicação e
compreensão das perguntas.

Os estudantes de Medicina da UCB, entre o 2º e
o 6º ano, formularam o questionário destinado às
entrevistas, composto por 18 perguntas objetivas
e 29 subjetivas, dentre as quais foram destacadas
14 para compor o trabalho (**Tabela 1**), totalizando
uma média de 40 minutos por entrevista.

Tabela 1 – Perguntas objetivas e subjetivas feitas para condução das entrevistas com os idosos, 2022.

Perguntas objetivas	Perguntas subjetivas
1. Nome completo	1. Qual a percepção sobre a morte?
2. Faixa etária	2. Como era a percepção quanto à morte antes da pandemia? Mudou durante a pandemia?
3. Sexo	3. Qual o papel da religião na percepção sobre a morte?
4. Região e cidade	4. Qual a percepção em relação à saúde mental? Era diferente antes da pandemia?
5. Região administrativa (caso more no Distrito Federal)	5. Qual o papel da religião sobre a saúde mental?
6. Grau de escolaridade	6. Sentiu solidão durante a pandemia?
7. Renda mensal	7. Como as notícias sobre a pandemia nos jornais e redes sociais afetaram sua saúde mental
8. Número de pessoas que habitam junto	8. Costumava ir a sessões de terapia antes da pandemia?
9. Número do telefone	9. Foi a sessões de terapia durante a pandemia?
10. Crença em Deus ou força superior?	10. Usou algum medicamento para evitar a COVID-19? Se sim, qual e por que?
11. Participa de alguma religião?	11. Costumava tomar medicamentos por conta própria antes da pandemia? E atualmente?
12. Frequência à igreja ou serviço religioso	12. Utiliza dispositivos tecnológicos? Se sim, quais?
13. Posse de dispositivos conectados à internet	13. Qual tipo de conteúdo mais consome pelos aparelhos tecnológicos?
14. Teve COVID-19? Caso sim, precisou ser internado?	14. Percebe alguma mudança na rotina com o uso dos aparelhos eletrônicos?
15. Doenças diagnosticadas	
16. Medicamentos em uso	
17. Passou a tomar medicamentos após a pandemia?	
18. Capacidade de andar sozinho sem qualquer tipo de ajuda	

Os voluntários foram recrutados pelos alunos

no ambiente universitário, enquanto aguardavam

ais (Facebook e Instagram) e mensagens instantâneas

Antes das entrevistas, foi realizada a leitura do TCLE, explicando os objetivos do projeto e verificando a possibilidade de gravação. Após a aceitação do participante, as entrevistas foram iniciadas. Os entrevistados receberam as transcrições e tiveram a oportunidade de fazer as correções necessárias. Os participantes estão sendo informados gradualmente dos resultados, e aqueles que já os receberam nos deram *feedbacks* extremamente positivos.

As informações foram obtidas pelo formulário eletrônico do *Google Forms*. Posteriormente, os dados foram processados pelo *software Interface de R pour l'analyse Multidimensionnelle de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ)*, versão 0.7 alpha 2, um programa livre que se ancora no *software R*, e permite processamento e análises estatísticas de textos produzidos. Esse *software* possibilita diversos tipos de análise de dados,

de Palavras" e a "Classificação Hierárquica Descendente (CHD)".¹³

As informações qualitativas foram analisadas conforme o conteúdo de Bardin (2010), utilizando o *software IRAMUTEQ*, com apresentação da Nuvem de Palavras e da CHD, além da interpretação das narrativas por uma temática dedutiva.

Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UCB, conforme Resolução do CONEP/CNS 466/12, sob número do CAAE 51397821.0.0000.0029 e aprovação n.º 5.327.871. Os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Resultados

Cento e setenta e um idosos participaram da pesquisa, dos quais 70,2% eram mulheres e 29,8% homens, ambos prevalentes na faixa etária de 60 e 65 anos (36,3%) (**Tabela 2**).

Tabela 2 – Distribuição segundo às variáveis sexo, frequência em sessões de terapia, uso de medicamentos diários, infecção por COVID-19 e uso de tecnologias durante a pandemia, 2022.

Variáveis	n	%
Sexo		
Masculino	51	29,8
Feminino	120	70,2
Sessões de terapia antes da pandemia		
Sim	30	17,5
Não	141	82,5
Sessões de terapia durante a pandemia		
Sim	15	8,8
Não	156	91,2
Uso de medicamentos diários		
Sim	142	83
Não	29	17
Infecção por COVID-19		
Sim	77	45
Não	94	55
Uso de tecnologias na pandemia		
Sim	168	98,2
Não	3	1,8
Religiosidade		
Sim	156	91,2
Não	14	8,2
Missing system	1	0,6

Outra pergunta foi sobre o uso de medicamentos diários, na qual 83% dos entrevistados afirmaram tomar pelo menos um tipo de medicamento diariamente, sendo prevalentes as doenças cardiovasculares (56.7%), dislipidemias (36.8%)

Por fim, foi questionado sobre o uso de dispositivos tecnológicos e da internet. Cerca de 98,2% fazem uso de algum tipo de dispositivo ligado à internet, enquanto apenas 1,75% negaram (Tabela 2).

Os dados foram organizados a partir do material obtido nas entrevistas e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin¹³, com uso do software *IRAMUTEQ*, que permitiu a utilização da Nuvem de Palavras e da Classificação Hierárquica Descendente (CHD).

A nuvem de palavras organiza, de forma gráfica, as palavras em função da sua frequência, permitindo uma rápida identificação das principais palavras do *corpus* textual, que reúne os textos originados pelas entrevistas (**Figura 1**).



Fonte: Elaboração própria.

Outra técnica utilizada foi a CHD, que classifica os segmentos de textos (ST) conforme sua ocorrência. O corpus geral foi composto

O conteúdo foi categorizado em cinco

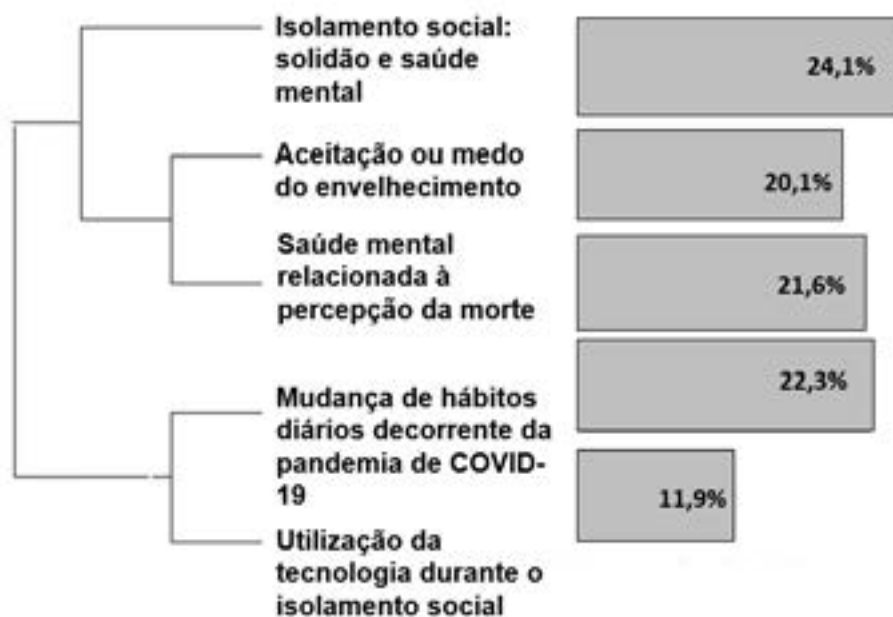


Figura 2 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 2022.

Fonte: Elaboração própria

Classe 1 – Isolamento social: solidão e saúde mental (24,1%)

24,08% (f= 50 ST) do corpus total analisado. Constituída por palavras e por radicais no intervalo entre $\chi^2 = 28.35$ (querer) e $\chi^2 = 445.05$ (Casa). Composta pelas palavras: "Isolamento" ($\chi^2 = 215.35$); "Solidão" ($\chi^2 = 166.44$); "Triste" ($\chi^2 = 107.88$); "Preocupado" ($\chi^2 = 29.34$).

Descrição do enfrentamento do isolamento social. Foram relatados sentimentos de tristeza e solidão devido ao afastamento de entes queridos, afetando a saúde mental. Pode-se relacionar a solidão durante o período pandêmico à saúde mental, uma vez que a vida social é uma necessidade da natureza humana e, por isso, o ser humano precisa de contato com grupos para se sentir feliz.

A gente tenta ver o mínimo possível de notícias ruins, eu ligo a televisão e só vejo tragédia, aí a gente fica deprimido, com medo das coisas. (ind 152)

Aí de repente eu fiquei dentro de casa, trancada aqui (...) e disse: vou endoidar. (ind 027)

Eu acho que o isolamento teve um gran-

de passeio (...) tinha um certo receio. (ind 154)

Classe 2 – Mudança de hábitos diários decorrente da pandemia de COVID-19 (22,3%)

22,28% (f = 50 ST) do corpus total analisado. Foi composta por palavras e por radicais no intervalo entre $\chi^2 = 49.02$ (usar) e $\chi^2 = 1892.02$ (tomar). Composta pelas palavras: "Vacina" ($\chi^2 = 820.83$); "Exercício" ($\chi^2 = 534.16$); "Medicamento" ($\chi^2 = 443.86$).

Essa classe relaciona a pandemia aos hábitos diários dos idosos, como a automedicação. Muitos tomaram o "kit COVID" por influência de médicos ou das notícias midiáticas. A grande maioria afirmou só tomar medicamentos para doenças com diagnóstico e sempre sob prescrição médica.

Não uso medicamentos por conta própria. Não usei o kit covid. Tomei as 3 doses da vacina porque fui obrigado. (ind 037)

Uma coisa que melhorei muito, foi alimentação. Não tomamos remédios. A gente só tomou as vacinas mesmo e algumas vitaminas. Tudo que falavam

dio não, só a vacina. (ind 169)
ivermectina eu tomei, mas não foi
ação médica. Meu médico não fi-
em sabendo. Faço pouca atividade
física (...). Faço uns exercícios normais de
aquecimento em casa. (ind 121)

Classe 3 – Utilização da tecnologia durante o isolamento social (11,9%)

11,89% (f = 50 ST) do corpus total analisado, integrada por palavras e por radicais no intervalo entre $\chi^2 = 6.35$ (ocupar) e $\chi^2 = 1145.88$ (celular). Composta pelas palavras: "Tecnologia" ($\chi^2 = 948.64$); "Dificuldade" ($\chi^2 = 465.42$); "Comunicar" ($\chi^2 = 129.43$); "Notícia" ($\chi^2 = 71.33$).

Essa classe informa sobre a utilização da tecnologia pelos idosos. Os voluntários, em sua quase totalidade, afirmaram ter utilizado qualquer meio tecnológico, durante o isolamento social, para se comunicar com amigos e familiares. Dentre os conteúdos consumidos pelos idosos, estão as redes sociais, serviços de *streaming* e o YouTube. A televisão perdeu espaço, como uma forma de preservação da saúde mental, ao evitar notícias ruins.

Assistia todos os dias o culto (...), porque as igrejas foram fechadas, mas eles faziam o culto online. Através da tecnologia eu falo com a minha família de onde eles estão, e através dela estamos atentos sobre muitas coisas. (ind 133)

Eu vejo mais filmes pelos aparelhos tecnológicos. Eu acho que você precisa saber usar a internet (...), porque o Instagram prende muita gente, não é? (...), aí você acaba ficando muito tempo na internet e vira um hábito. (ind 101)

Sim, eu usava tecnologia antes da pandemia. Uso muito o celular, o Whatsapp e o Facebook. Acho que a tecnologia veio para melhorar. Tem hora que é chato, mas veio para melhorar. Hoje você fica sabendo de tudo. (ind 098)

Classe 4 – Aceitação ou medo do envelhecimento (20,1%)

20,13% (f = 50 ST) do corpus total, que está constituído por palavras e por radicais no

"Experiência" ($\chi^2 = 105.52$); "Felicidade" ($\chi^2 = 53.08$).

Constata-se a percepção dos idosos em relação ao envelhecimento, em que os pontos principais foram a naturalidade do envelhecimento. A grande maioria demonstrou aceitação, trazendo aspectos positivos, como aprendizados, vivências e experiências. Trouxeram, também, pontos negativos, como o aparecimento de doenças, hipofunção orgânica e corporal e aproximação da morte. Foi perceptível a relação entre o envelhecimento e a saúde mental dos entrevistados. Aqueles que consideraram sua saúde mental como "boa e estável", tinham uma percepção positiva sobre o envelhecimento. No entanto, os que classificaram a saúde mental como "ruim", tinham medo.

O envelhecimento é uma bagagem com bastante aprendizado e muita experiência de vida. Eu vejo pontos negativos no envelhecimento, como a energia que a gente já não tem mais como antes e as dores. (ind 058)

O processo de envelhecer, não sei se vejo como positivo. Envelhecer é cruel. Eu acho que é bonito a pessoa poder envelhecer, porque ela passa por etapas da vida, (...) é bacana, mas eu acho muito sofrido, (...) a alegria que eu tinha quando jovem, hoje eu não tenho mais. (ind 046)

Para mim envelhecer é algo positivo, não gosto de nada negativo para mim, quando tem algo negativo eu saio de perto. (ind 140)

Classe 5 – Saúde mental relacionada à percepção da morte (21,6%)

21,63% (f = 50 ST) do corpus total analisado. Constituída por palavras e por radicais no intervalo entre $\chi^2 = 31.2$ (reencarnação) e $\chi^2 = 868.69$ (Deus). Composta pelas palavras: "Morte" ($\chi^2 = 735.9$); "Fé" ($\chi^2 = 267.6$); "Medo" ($\chi^2 = 155.03$); "Saúde mental" ($\chi^2 = 47.69$).

Trata-se da percepção dos idosos em relação à morte e a conexão com a saúde mental de cada um. A grande maioria demonstrou aceitação em relação à ideia de morte, uma vez que a religião

incípio, eu tenho medo da morte, mas tem dias que nas minhas orações, com fé, aí muda. Eu já acho que será uma coisa natural que todos nós temos que passar (...). Ao mesmo tempo que você tem medo, você se agarra na sua fé e você se prepara para quando chegar o momento, você partir sem dor e sem agonia. (ind 171)

A gente vai ficando velho e vai aceitando com naturalidade. Hoje em dia eu não tenho mais nem medo da morte, sabia? (...), hoje em dia eu vejo como uma coisa que vai acontecer e acho que ela vai ser boa para mim. (ind 001)

Eu não tenho medo da morte. Tenho medo mais é do jeito de morrer, medo de doença, de ficar em cima de uma cama, mas tenho esperança de que Deus vá me levar. (ind 071)

Discussão

Este estudo objetivou analisar a vida dos idosos durante a pandemia de COVID-19, relacionando o uso diário de medicamentos, a saúde mental e a frequência em sessões de terapia antes e durante o período pandêmico.

Estudos mostraram que idosos acima de 60 anos foram o grupo com maior risco de mortalidade, taxa de hospitalizações e admissões em unidades de terapia intensiva.¹² É notório que as manifestações clínicas e a gravidade da doença parecem ser mais exacerbadas com o avançar da idade e com a presença de comorbidades, fato este que torna os idosos o principal grupo de risco da COVID-19.¹⁴

O artigo de Grolli et al.² afirma que os mais acometidos pelo novo coronavírus eram idosos portadores de doenças crônicas. Idosos com distúrbios psiquiátricos podem apresentar uma reação inflamatória orgânica mais persistente, devido à insuficiência do sistema imunológico, facilitando a ocorrência de infecções. Ademais, o isolamento social imposto, contribuiu para o aumento da ansiedade, do medo e da insegurança.

O estudo De Oliveira et al.³ confirma que há prejuízo da saúde mental na população idosa,

isolamento social desencadeou vários agravos, como estresse, predisposição ao surgimento de ansiedade, medo e depressão.¹⁵

A partir desses estudos, pode-se comparar com a pesquisa em questão. Durante uma pandemia, o medo aumenta a ansiedade e o estresse em pessoas saudáveis e intensifica os sintomas daqueles com transtornos psiquiátricos pré-existentes.¹⁶ A grande maioria afirmou que o isolamento social proporcionou uma piora da saúde mental, já que as medidas estiveram voltadas para a saúde física dos indivíduos, promovendo uma ameaça à integridade psicológica. Dessa forma, muitas pessoas recorreram à religiosidade ou à espiritualidade, uma vez que tem grande potencial de impacto na saúde mental, já que assume papel essencial na vida dos indivíduos, auxiliando no enfrentamento das adversidades da vida.¹⁷

Contudo, mesmo que alguns tenham classificado sua saúde mental como "ruim", grande parte negou a ida à terapia. Muitos não se mostraram interessados em procurar ajuda profissional para tratamento da ansiedade e da depressão. Dessa forma, a frequência a sessões de terapia entre os entrevistados foi baixa.

De Fátima Souza et al.¹⁸ aborda a automedicação dos idosos durante a pandemia, relacionada à veiculação de informações inverídicas. Pelo medo da infecção, a população mudou hábitos diários e fez uso de medicamentos não comprovados cientificamente. A automedicação tornou-se comum, prática que é realizada por cerca de 77% dos brasileiros, conforme o Conselho Federal de Farmácia em 2019¹⁹, e levou a um consumo aumentado e descontrolado de medicamentos pelos indivíduos. Muitos remédios veiculados pela mídia, como o "Kit COVID", não eram comprovadamente eficazes contra essa doença, propiciando um alto risco de interações medicamentosas, dificuldade de diagnóstico por mascaramento de sintomas e agravamento do quadro clínico.^{19, 20} Assim, ressalta-se a importância de informações com embasamento

a tecnologia garantiu acesso às informações sobre a situação, permitiu o contato com amigos e familiares e proporcionou uma forma de entretenimento. Além disso, promoveu uma maior inclusão da população idosa no mundo tecnológico, uma vez a tecnologia tende a estar cada vez mais presente na sociedade, o que foi intensificado durante o período pandêmico.²¹

Conclusão

Após realização do projeto, análise de dados e interpretação dos resultados obtidos, pode-se concluir que os objetivos da pesquisa foram cumpridos. Há relação entre a existência de doenças crônicas e distúrbios psiquiátricos em idosos, com maior gravidade dessa doença. Ademais, houve agravamento da saúde mental durante esse período, frequentemente negligenciada em detrimento da saúde física. Embora muitos tenham relatado "saúde mental ruim", a maioria recusou a ida à terapia. Houve aumento significativo da automedicação, impulsionado por notícias falsas midiáticas. Por fim, o uso da tecnologia facilitou o acesso a informações, conexões sociais e entretenimento para os idosos, inserindo-os na sociedade digital.

Como limitações, o estudo apresentou um número relativamente pequeno de voluntários, dificuldades para encontrar idosos que se dispusessem a participar e o espaço amostral limitado.

Assim, esse estudo poderá ajudar como complemento de informações para estudantes e profissionais que desejam se aprofundar em temas relacionados, principalmente nas áreas de Gerontologia, Medicina e Psicologia, uma vez que compara dados científicos e relações humanas, visando um envelhecimento mais saudável e digno.

8. Velho FD, Herédia VB Quarantined senior citizens and the impact of technology on their life. RSV-TH. 12 jul. 2020 [citado 15 dez. 2023];12(Especial):1-14.

Fernanda Fagundes Costa

Estudante de Medicina da Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil.

Vicente Paulo Alves

Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), em São Bernardo do Campo, SP, Brasil. Professor no PPG em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil.

Fernanda Fagundes Costa

Universidade Católica de Brasília
QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, 71966-700
Brasília, DF, Brasil

*Os textos deste artigo foram revisados pela SK
Revisões Acadêmicas e submetidos para validação
do(s) autor(es) antes da publicação.*